

Fecha Última Actualización: 17-04-2022 15:11:34

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Nancy Gladys Barra Vasquez
Edad : 76a 4m 23d
Dirección : Jorge Ross Ossa 487 Casa E

Rut : 5.827.854-8
Fecha Nacto: 25/11/1945
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1100267
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 8887 6200

N° Epicrisis
300943

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Hospitalización

Fecha Ingreso : 26/03/2022 19:39

Días Estadía: 22

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 17/04/2022 15:04

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EGRESO UPC 17/04/2022

Nombre: Nancy Gladys Barra Vásquez
RUT: 5827854-8
Edad: 76 años
FI HSR: 26/03/2022
FI UPC: 28/03/2022

ANTECEDENTES:

1. Médicos: Linfoma no Hodgkin folicular en QT (R-COP último ciclo 09/02/21), Cáncer de mama operado (1988 mastectomía parcial derecha + RT / 2004 mastectomía total derecha), TVP (2004), EAOC (usuaria de TACO), Hipoacusia.
2. Quirúrgicos: Mastectomías. Múltiples cirugías de revascularización Ao-iliaca (2005, 2009, último bypass Ao-bifemoral 2015).
3. Alergias: No.
4. Fármacos: Amoxicilina/clavulánico (uso permanente indicado por vascular por sospecha de infección de material protésico), Atorvastatina 10 mg/día, Acenocumarol según esquema.
5. Hospitalizaciones recientes: No.
6. Inmunizaciones: SINOVAC 3 dosis. Influenza (-) desde el año 2020.

ANAMNESIS:

Paciente con antecedentes descritos, con antecedente de PCR COVID (+) desde el 19/03. Consulta en SAPU por cuadro de 3 días de evolución de persistencia de fiebre, asociado a disnea y tos. Se deriva a SU HSR, al ingreso taquicárdica (101 lpm), hipertensa (152/66 - PAM 101), afebril (36.5°C), taquipneica (23 rpm) y saturando 92% con MAF. Se describe vigil, tranquila, bien hidratada y perfundida, con MP (+) con crépitos bibasales y sin UMA.

Se decide conectar a CNAF por aumento de FR y desaturación hasta 84% con FiO2 al 100%.

Se realiza angioTAC de tórax por antecedente de TVP previa que se informa negativo para TEP, con hallazgos compatibles con una extensa neumopatía multilobar y patrón altamente sugerente de Covid-19. Exámenes de ingreso evidencian PCR 151, sin leucocitosis, hipokalemia leve sin falla renal e INR 1.81. Se inicia manejo con dexametasona.

Durante la mañana del 27/03 paciente evoluciona con aumento de requerimientos de O2 y desaturación, se controla PaFi que cae a 88, por lo que se decide IOT y conexión a VMI con parámetros protectores. Se inicia sedoanalgesia con midazolam y fentanilo, además de BNM con rocuronio logrando SAS 1. Se instala CVC YD. Se inicia NAD en dosis bajas en contexto de

Fecha Epicrisis : 17/04/2022 15:11

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 17-04-2022 15:11:34

Página 2 de 3

sedoanalgesia, la que se suspende hoy AM.
Se ingresa a UPC para continuar manejo.

IMÁGENES RECIENTES:

26/03 AngioTAC: En el tórax se identifican múltiples opacidades parenquimatosas pulmonares bilaterales con densidad en "vidrio esmerilado" asociado a engrosamiento de septos inter e interlobulillares lo que son más confluentes de predominio peribronquiales en lóbulos inferiores. Patrón altamente sugerente de Covid-19.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO A UCI:

1. Insuficiencia respiratoria aguda:

a. Neumonía COVID-19.

b. Sospecha sobreinfección

c. Fecha inicio de síntomas 17/03.

d. PCR (+) 19/03.

Antecedentes: LNH folicular en QT, Ca mama operado, TVP, EAOC, usuaria de TACO.

EVOLUCIÓN EN UCI

1. Hemodinámico: Requirió DVA en contexto de sedación a su ingreso a UCI suspendidas precozmente. Durante últimas 24 horas previo a su fallecimiento, inició nuevamente NAD en contexto de shock séptico de foco pulmonar asociado a NAVM.
2. Ventilatorio: A su ingreso cursando falla respiratoria grave. Requirió sedación profunda en SAS 1 + BNM con Rocuronio y Prono por 72 horas. Posteriormente se supina con adecuada respuesta gasométrica (PaFi peri 300). Posterior suspensión de BNM y luego sedación paulatinamente. Se logra extubar el 04/04 con salida a VMNI. Posterior a extubación se mantuvo siempre dependiente de VMNI con ventanas exclusivamente a CNAF. Desde el 12/04 con requerimientos de soporte ventilatorio al alza en contexto de NAVM con mala mecánica respiratoria y permanencia de requerimientos de VMNI. Jefatura de módulo conversa con familiares decidiéndose proporcionalización de manejo y no re intubación ni conexión a VMI.
3. Infeccioso: A su ingreso recibió curso de ATB con Ampicilina/Sulbactam. Posteriormente desarrolló NAVM sin lograr identificar MO causal. Con mala respuesta a Imipenem empírico se inició Colisitin + Vancomicina sin respuesta.

Día 17/04 se encuentra a paciente en muy malas condiciones. Con manejo de disnea con Morfina hasta 8 mg/hr, comprometida de conciencia, en VMNI. Conversado con familiares no re intubación. Se llama a hija tutora (Claudia), quienes acuden a acompañar a Nancy. Se pasa soporte ventilatorio a O2 por NRC. Fallece a las 11:00 hr acompañada de familiares. Se entrega certificado de defunción.

Dr. Tomás Lahera Frohmann
UPC CASR

Diagnóstico de Egreso

Neumonía Viral - Neumonía COVID
Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallecido

Plan Post Alta

Fallecido

Indicaciones

Tipo de Reposo : Absoluto

Régimen Alimentario : Régimen Cero

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 17/04/2022 15:11

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:52

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 17-04-2022 15:11:34

Página 3 de 3

Bec. Claudia Estefanía Marín Heis

BECADO

Becado/Residente

Tomás Lahera Frohmann

Médico Tratante (Staff)